

INTRODUCTION :

- Intoxication grave, fréquente, domestique (appareil de chauffage, chauffe-eau, incendies...).
- Gaz incolore, inodore, produit par combustion incomplète d'une source de carbone => tueur silencieux.
- Forte affinité à l'hémoglobine => formation de carboxyhémoglobine => dim du transport d'O₂ (hypoxie) + effet toxique direct par altération de la perméabilité de la membrane alvéolo-capillaire (hypoxie) et dim de l'activité du cytochrome oxydase (stress oxydatif).
- Clinique variée (neurologique, cardiovasculaire, respiratoire...)
- Antidote = oxygénothérapie+++.

DIAGNOSTIC POSITIF :

A- Interrogatoire : recueillir le maximum d'information sur :

Intoxiqué : âge, profession, tares associées.

Intoxication : durée d'exposition, contexte (appareil de chauffage, incendie...), conditions (patient vivant seul, atteinte d'entourage...)

B- Signes cliniques :

Phase de début : céphalées, vomissements, acouphènes, troubles visuels, impotence motrice...

Phase d'état :

1-Signes neurologiques : encéphalopathie anoxique

- Forme mineure : céphalées, nausées, vomissements, troubles visuels.
- Forme modérée : céphalées intenses, stupeur, hallucinations, confusion.
- Forme sévère : coma agité, troubles du tonus (ROT vifs, décérébrations, syndrome extrapyramidal, convulsions).

2-Signes cardio-vasculaires : inconstants

- Tachycardie, hypotension
- Collapsus cardiovasculaire, arrêt cardio-circulatoire
- Trouble rythme, trouble conduction et de repolarisation

3-Signes respiratoires : OAP, détresse respiratoire de degré variable (simple dyspnée -> **détresse respiratoire majeure**).

4-Signes cutanées : coloration cutanée rouge "cochenille".

5- Lésions associées : brûlures, blast, traumatisme...

6-Autres : Rhabdomyolyse, anurie, Pancréatite aigue....

C- Paraclinique :

diagnostic surtout clinique, la paraclinique est surtout à but pronostique

1. Biologie :

- Oxymétrie de pouls non fiable (problème d'utilisation d'O₂ par les tissus).
- Dosage d'HbCO : taux > 10% = critère diagnostique.
→ **Interpréter en fonction de : Notion de tabagisme / Délai par rapport à l'intoxication / Oxygénothérapie.**
- Gaz de sang : acidose métabolique, PaO₂ normale.
- NFS, Ionogramme : retentissement général de l'intoxication, Enzymes musculaires augmentés (CPK, LDH, Transaminases)....

2. Imagerie : radio pulmonaire = opacités alvéolaires, atélectasie.

3. Endoscopie : Fibroscopie bronchique (thérapeutique : aspirer les suies en cas d'intoxication aux fumées d'incendie et patient stable)

TRAITEMENT :

3 types de patients :

- Asymptomatiques.
- Comateux ou en arrêt cardio-respiratoire (PEC immédiate)
- Gravité intermédiaire (PEC adaptée au cas par cas).

A-Premiers gestes :

- Soustraire de l'atmosphère toxique + Secourisme : MCE, oxygénothérapie, ventilation mécanique.
- Rechercher la source de CO et la neutraliser.

B-En milieu hospitalier :

1- Hospitalisation + Mise en condition : position demi-assise, VVP, monitoring cardio-respiratoire, Bilan initial

2- Administration d'oxygène+++ : antidote de CO

- **Oxygène par sonde nasale à fort débit** (10L/min au moins pendant 12h).
- **Intubation-ventilation** : si oxygénation pas efficace, coma profond, SDRA ou collapsus vasculaire
- **Oxygénothérapie hyperbare** :
. Moyen le plus efficace : 1 séance d'une heure à une pression de 2 atmosphère.
. Meilleures indications : formes comateuses, femme enceinte (car Hb fœtale a une affinité plus élevée pour CO).

3- Mesures adjuvantes :

- Maintien des fonctions vitales : PEC d'un SDRA (intubation-ventilation), collapsus (remplissage)...
- Convulsions : Diazépam 0,5mg/kg (<20kg), 10 mg (>20kg).
- Hydroxocobalamine (vitamine B12) : 5g en perfusion rapide en cas d'intoxication aux cyanures associées (fumée d'incendie) avec état gravissime (instabilité HD arrêt cardiorespiratoire, trouble de conscience, acidose métabolique importante).
- PEC de lésions associées (brûlures, blast, traumatisme...).

4- Surveillance : état de conscience, état hémodynamique, état respiratoire, examen clinique, GDS.

CONCLUSION :

- Intoxication grave + Pronostic dépend de la durée et contexte d'intoxication, délai de PEC, âge, tares associées, autres toxiques associés
- Risque de séquelles et de syndrome post-intervallaire (3-4 semaines après l'intoxication : confusion, démence, céphalées intenses... => peut être prévenu par une oxygénation suffisante après l'intoxication).
- Décès peut survenir au début par l'hypoxie ou tardivement par SDRA, infections... -> Intérêt d'une PEC précoce et adaptée (oxygénothérapie+++).